

Examen clínico

Evaluación postural

“Debemos comprender que la postura no es más que, la posición general del cuerpo, la forma en la que mantenemos nuestra posición o nuestro cuerpo, de forma intencional o no intencional. En un aspecto artístico puede describir una pose o una posición mantenida a propósito con fines estéticos”.

En resumen, es la relación entre distintas partes del cuerpo, su alineación anatómica y como se posicionan unas con otras.

Es muy importante tenerlo claro, para poder hablar si existe una buena postura o mala postura o una postura independiente por cada ser humano.

Factores que influyen en una postura:



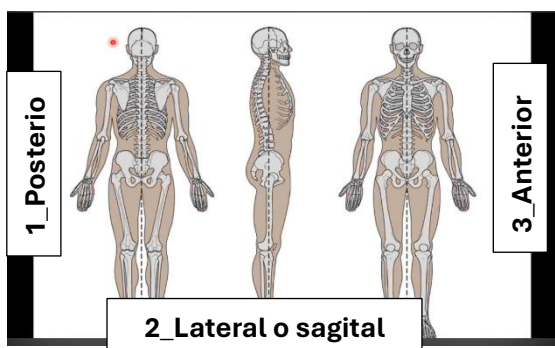
¿Efectos? Mala postura

Dolor musculo esquelético.

Restricción articular, limitaciones de movimiento a nivel articular.

Desventajas mecánicas, si existe dolor o limitaciones, no podremos realizar mis actividades diarias.

Debemos plantearnos lo siguiente a la hora de identificar el problema, “¿Qué será primero el huevo o la gallina? ¿Existirá una postura ideal? Anatómica, estructural o fisiológicamente, por lo que se ha estudiado la respuesta en sí.

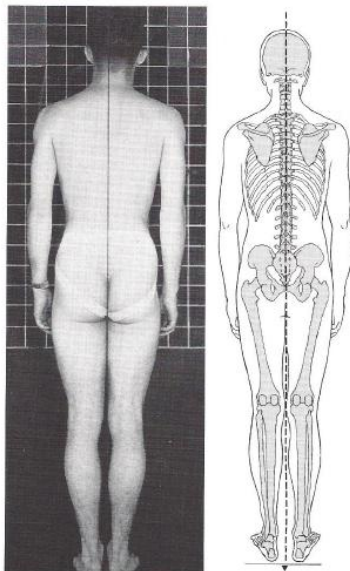


Cuando empleamos la línea o plomada de Kendall, podemos ver qué pasa de manera lateral con una línea axial (2), la cual divide al cuerpo en dos estructuras o partes, cuando todo esto está equilibrado y pasa por los puntos de referencia anatómicos correspondientes o antropométricos podremos decir que estamos en una postural ideal A o neutra.

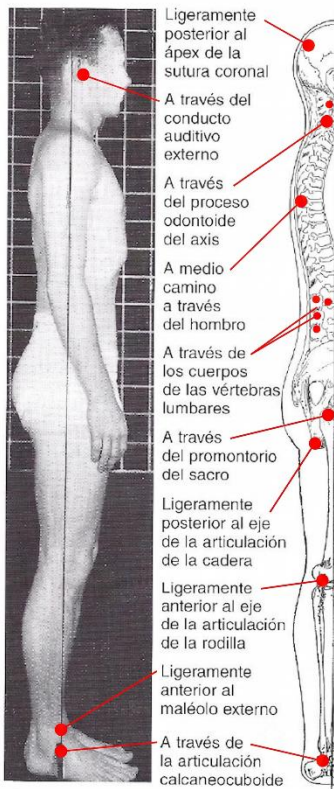
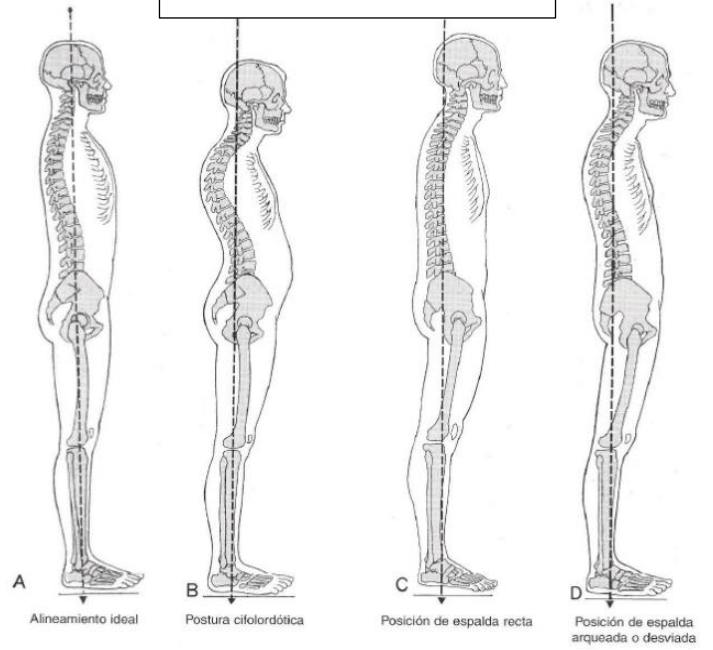
ALINEACIÓN EN PLOMADA IDEAL:
VISTA LATERAL



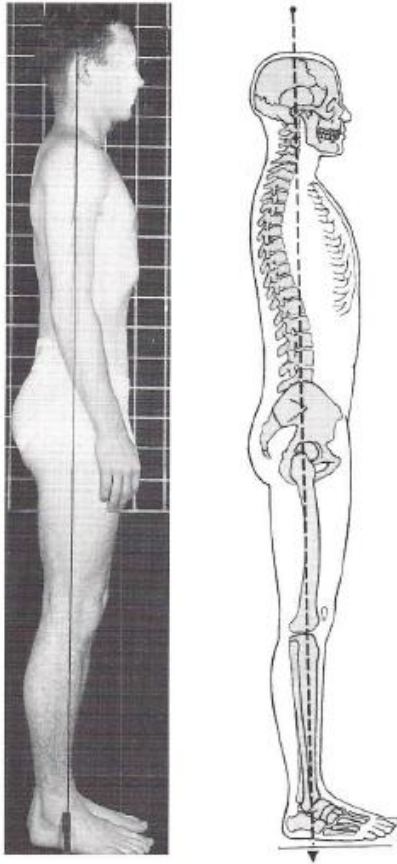
ALINEACIÓN EN PLOMADA IDEAL:
VISTA POSTERIOR



2_Lateral o sagital



A. Postura ideal



Cabeza: Posición neutra, ni inclinada hacia delante ni hacia atrás. (En la fotografía, ligeramente hacia delante.)

Columna cervical: Curva normal, ligeramente convexa hacia delante.

Escápulas: Tal como se observa en la fotografía, parecen estar en buen alineamiento, aplanadas contra la parte superior de la espalda.

Columna dorsal: Curva normal, ligeramente convexa hacia atrás.

Columna lumbar: Curva normal, ligeramente convexa hacia delante.

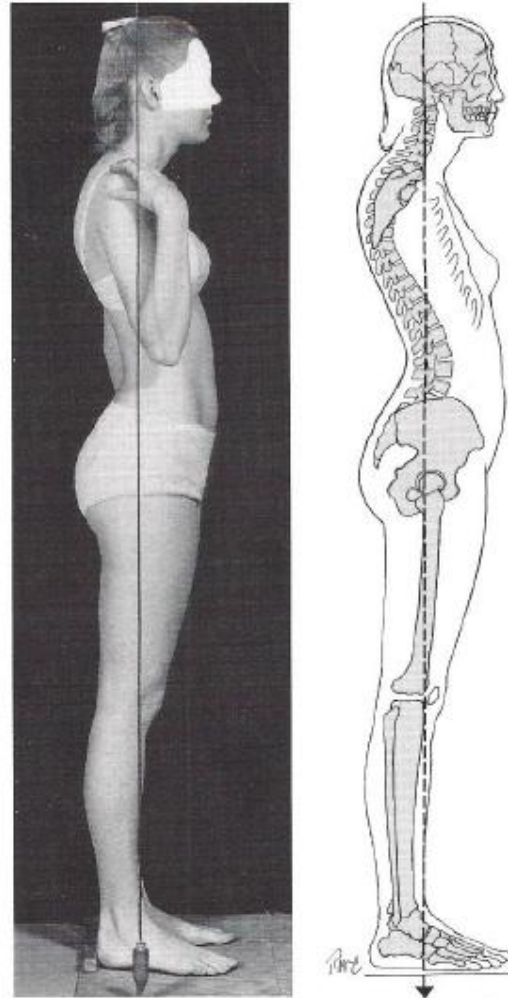
Pelvis: Posición neutra, las espinas antero-superiores en el mismo plano vertical que la sínfisis del pubis.

Articulaciones de la cadera: Posición neutra, ni flexionadas ni extendidas.

Articulaciones de la rodilla: Posición neutra, ni flexionadas ni hiperextendidas.

Articulaciones del tobillo: Posición neutra, pierna vertical y en ángulo recto con la planta del pie.

B. Postura cifolordótica



Cabeza: Hacia delante.

Columna cervical: Hiperextendida.

Escápulas: En abducción.

Columna dorsal: Flexión aumentada (cifosis).

Columna lumbar: Hiperextendida (lordosis).

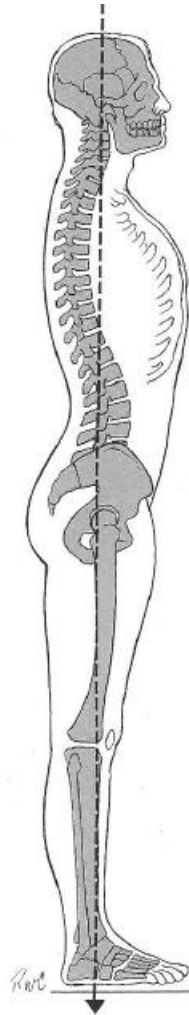
Pelvis: Inclinada hacia delante.

Articulaciones de la cadera: Flexionadas.

Articulaciones de la rodilla: Ligeramente hiperextendidas.

Articulaciones del tobillo: Ligera flexión plantar debida a la inclinación hacia atrás de la pierna.

C. Postura Lordótica o "Tipo"



Cabeza: Posición neutral.

Columna cervical: Curva normal (ligeramente anterior).

Columna dorsal: Curva normal (ligeramente posterior).

Columna lumbar: Hiperextendida (lordosis).

Pelvis: Inclinación anterior.

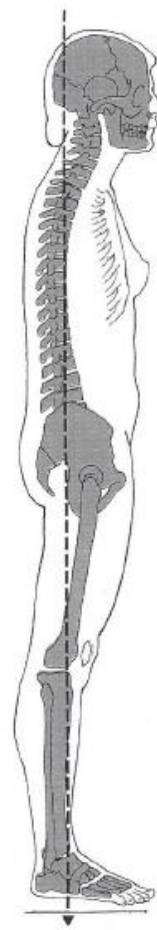
Articulaciones de la rodilla: Ligeramente hiperextendidas.

Articulaciones del tobillo: Ligeramente en flexión plantar

Músculos elongados:
Los músculos isquiotraqueales, pero

Músculos acortados:
res de la cadera.

B. Postura de espalda aplanada



Cabeza: Hacia delante.

Columna cervical: Ligeramente extendida.

Columna dorsal: Parte superior en flexión aumentada; parte inferior recta.

Columna lumbar: Flexionada (recta).

Pelvis: Inclinación posterior.

Articulaciones de la cadera: Extendidas.

Articulaciones de la rodilla: Extendidas.

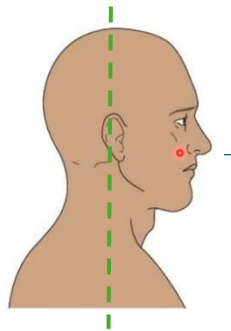
Articulaciones del tobillo: En ligera flexión plantar.

Músculos elongados:
de la cadera.

Músculos acortados:
Con frecuencia hipertrofiados. una ligera elongación normal, no se crea tensión en este

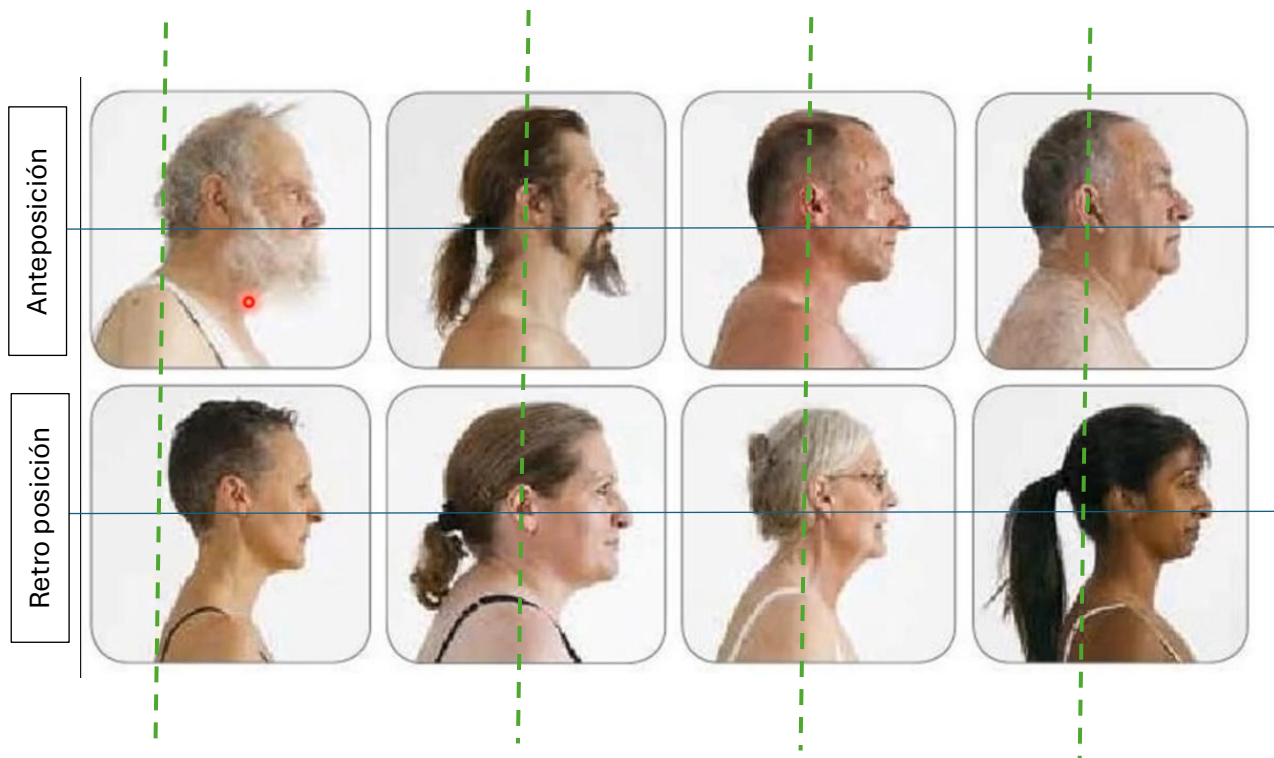
Posición de la cabeza y columna

- Ver también la unión cervico-torácica



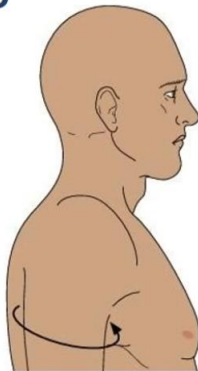
Debe existir la alineación de la punta de la nariz con el lóbulo o trago de la oreja, con el fin de identificar que la cabeza este alineada y no exista una anteposición o reposición.

¿Para que hacemos una evaluación postural?



Posición del Hombro

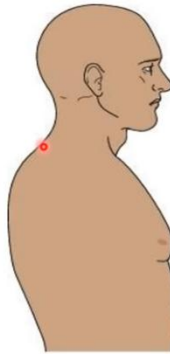
- Es uno de los cambios más notorios y comunes



Si bien el segmento de la cabeza puede estar alineado a los parámetros correctos, pero puede que haya cambios en la posición del hombro que pueden estar en anteposición o retropulsión y nos muestre que aparentemente la cabeza esta fuera de los parámetros normales, pero en este caso podrían ser los hombros.

Tórax

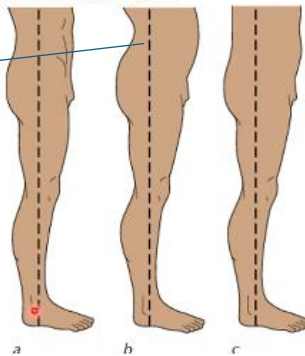
- Forma y alineación



El tórax nos va a mostrar una forma y alineación de sus parámetros ya presentes, y tenemos que seguir todas las curvaturas que se presentan a nivel lateral en la columna.

Abdomen y columna lumbar

Hiperlordosis



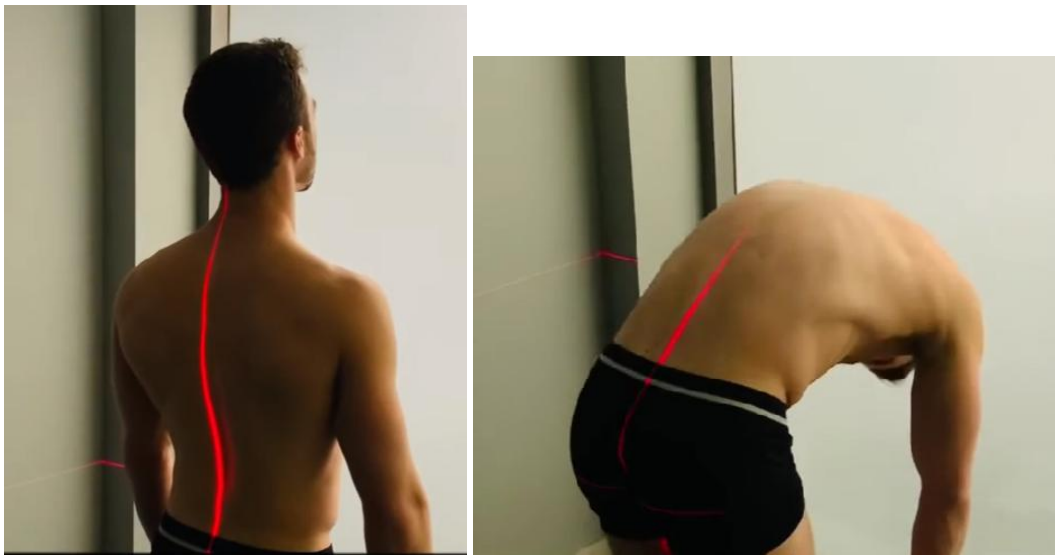
La plomada de Kendall debe pasar correctamente por el lóbulo de la oreja, por el acromion, por el trocánter mayor y llegue al maléolo externo, para mostrarnos un equilibrio en la postura del Px.

Vertical de Barré

Es una prueba de posturología clínica utilizada para evaluar cómo el cuerpo distribuye su peso frente a la gravedad y detectar desequilibrios musculoesqueléticos. Se realiza colocando al paciente de pie para alinear su postura con una plomada o línea láser.

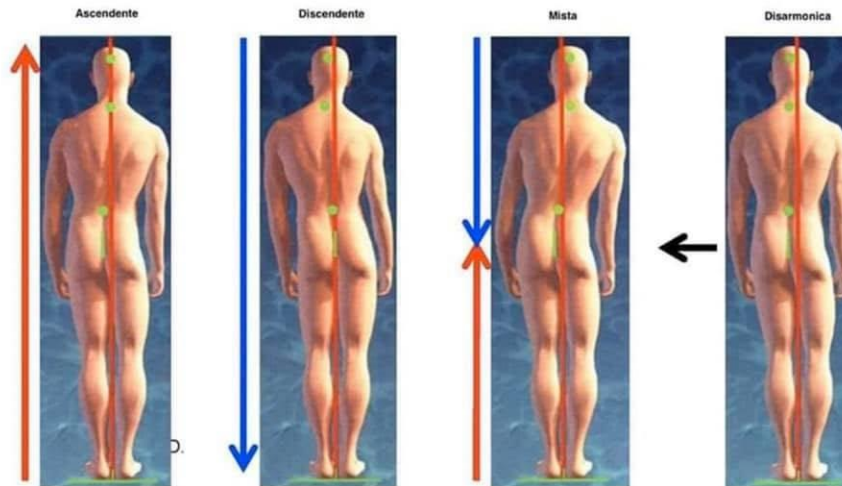
Los puntos para tomar en cuenta son:

- Occipital
- Vértebra C7 (en la base del cuello)
- Vértebra L3 (zona lumbar)
- Línea interglútea
- Mitad de la distancia intermaleolar

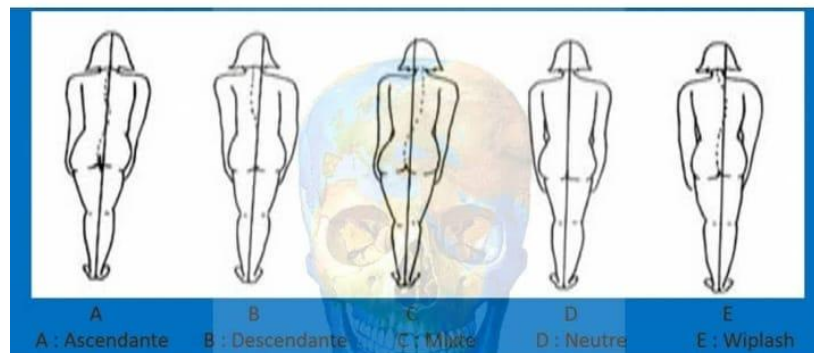


<https://www.youtube.com/watch?v=W5NKoIf8Pc>

En fisiología, estos puntos están normalmente alineados, pero podemos encontrarlos desalineados en diferentes formas.



VERTICAL DE BARRÉ



- A → La desviación de la vertical se encuentra en el tren inferior**
- B → La desviación de la vertical se encuentra en el tren superior**
- C → El cuerpo equilibra la desviación del tren superior con otra al lado contrario en el tren inferior**
- D → Neutro**
- E → Desviación de la vertical de todo el cuerpo en el mismo sentido**

 622417635

Síndrome ascendente: desplazamiento del pliegue glúteo hacia un lado. La causa del desequilibrio postural se encuentra debajo del centro de gravedad, por ejemplo, el receptor podálico.

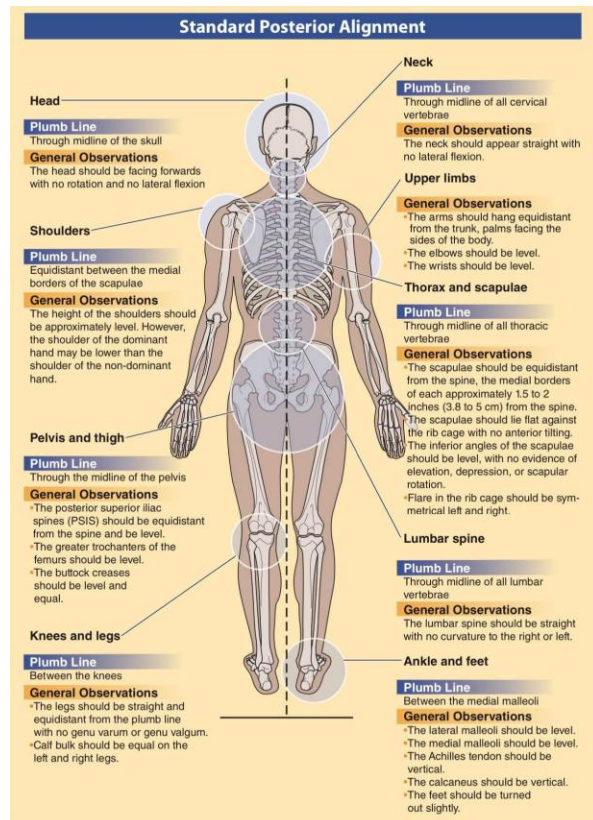
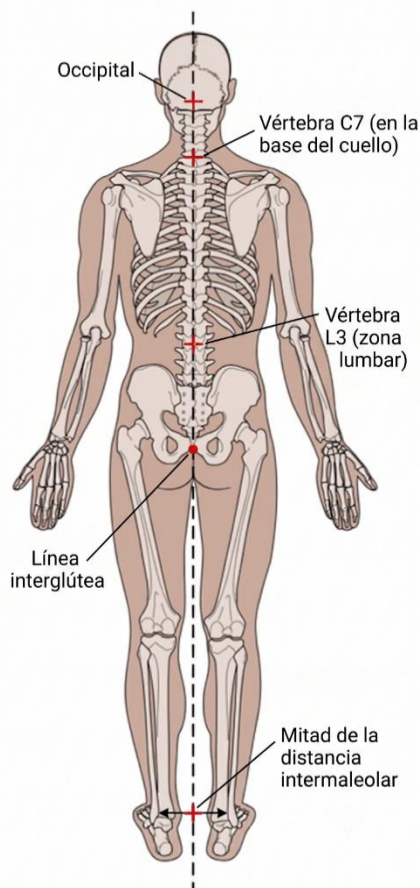
Síndrome descendente. desplazamiento a un lado del vértice de c7 o del occipucio La causa del desequilibrio postural debe buscarse por encima del centro de gravedad.

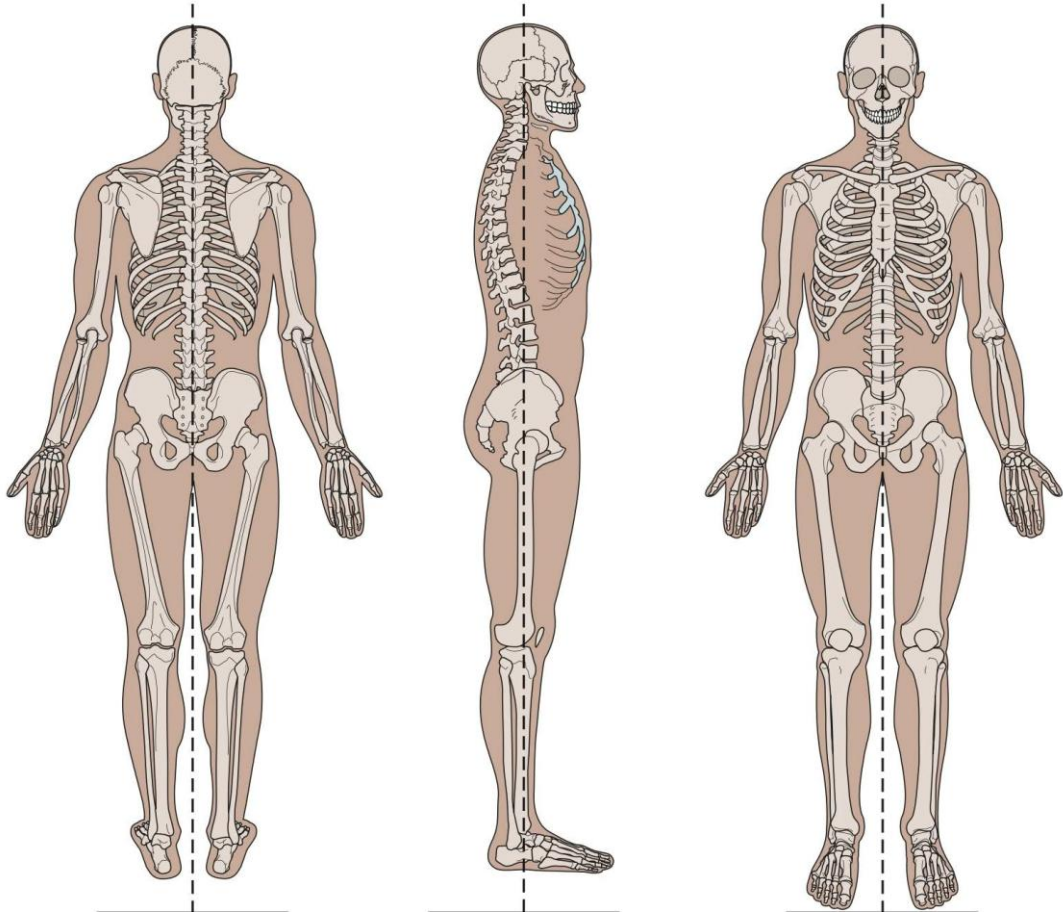
Síndrome mixto: ocurre con el desplazamiento del pliegue glúteo en un lado y el occipucio en el lado opuesto.

Síndrome Disarmonico: caracterizado por el desplazamiento de todos los puntos de referencia en el mismo lado; Es una imagen que se presenta después de un trauma como Whiplash (Whiplash) o para trastornos neuro-vestibulares o neurológicos .

<https://www.facebook.com/ortognatodoncia/photos/la-vertical-de-barre-es-un-sistema-de-evaluaci%C3%B3n-global-de-la-alineaci%C3%B3n-entre-l/2290826321213730/>

IMAGEN PARA TOMAR DE REFERENCIA (LA LINEA PLOMADA QUE DEBE DE APARECER)





<https://www.slideshare.net/slideshow/evaluacinposturalpdf/251706963#9>

Podríamos decir que cada persona tiene una postura adecuada a su forma de biotipo y actividad, la razón es porque cuando estamos más cerca de una postura ideal, vamos a hacer menos esfuerzos de estirar, de hacer una actividad y lo más importante, vamos a evitar daños colaterales con la desviación de algún segmento anatómico que se pueda presentar con el tiempo.

Beneficios.



¿A quienes se les hace este tipo de evaluación?

Pacientes con dolor “poco específicos”, dolor que se irradia a todos lados.

Pacientes pocos estables, con inestabilidad ligamentosa.

Pacientes con alteraciones posturales por dolor o lesiones.

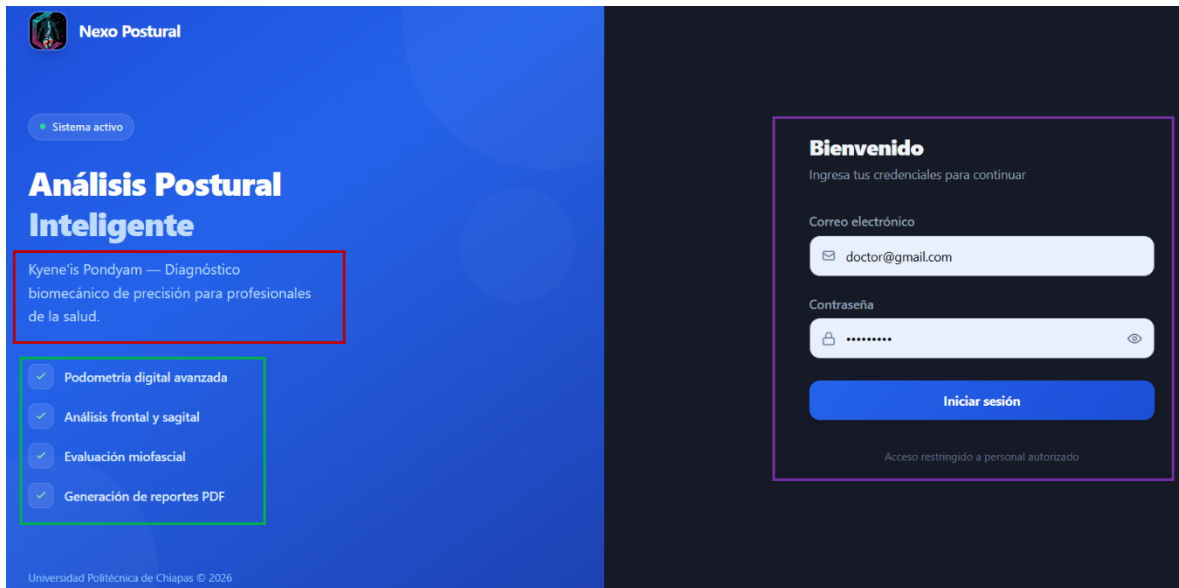
Como realizar el examen:

Lugar cómodo, Temperatura adecuada, La menor cantidad de ropa, Comodidad del Px, Podoscopio.

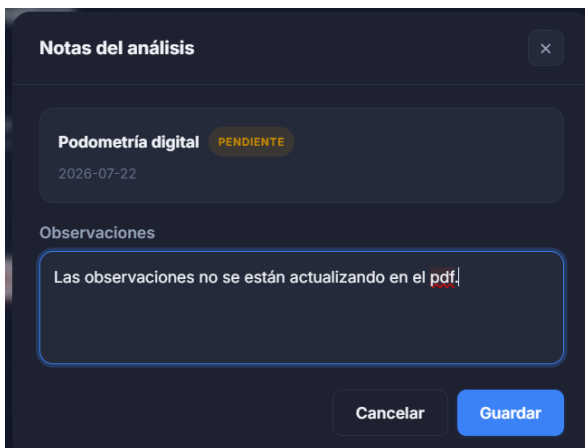
¿Qué significan nuestros hallazgos?

Podremos identificar de la cabeza hasta la base de sustentación, si hay equilibrio de los segmentos que se evalúan en el plano posterior, lateral y anterior.

Correcciones y observaciones:



1. Nosotros no realizamos diagnósticos, cámbialo por lo siguiente:
“Soporte biomecánico para análisis de precisión para profesionales de la salud”
2. Análisis frontal y sagital, cámbialo por lo siguiente:
Análisis anterior, lateral y posterior.
3. Agregar la opción de crear un perfil o registro.



Las notas u observaciones clínicas no se están actualizando para poder exportarlas en el pdf.

En el caso que se necesitara editar la observación clínica tendríamos que generar un nuevo test y las observaciones que se anotan como notas, solo quedan como internas, pero no exportables.



ÁNGULO TIBIOFEMORAL (FRONTAL)

EVALUACIÓN DEL ÁNGULO TIBIOFEMORAL (ANTERIOR O FRONTAL).

ÁNGULO TIBIOFEMORAL (SAGITAL)

EVALUACIÓN DEL ÁNGULO TIBIOFEMORAL (LATERAL O SAGITAL).

ALINEACIÓN VERTICAL SAGITAL

EVALUACIÓN POSTURAL BASADA EN LA LÍNEA PLOMADA DE KENDALL

VERTICAL DE BARRÉ

EVALUACIÓN POSTURAL BASADA EN LA VERTICAL DE BARRÉ

CADENA MIOFASCIAL

EVALUACIÓN DE CADENAS MIOFASIALES

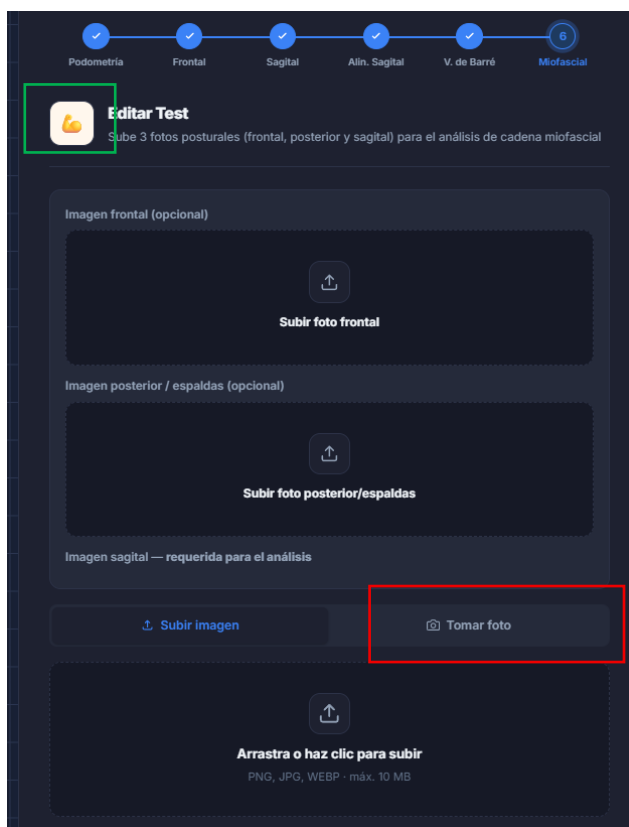


Imagen frontal = “ Imagen anterior / frontal” sin opcional.

“Imagen posterior / espalda” sin opcional.

Imagen sagital = “Imagen lateral / sagital” sin opcional.

Todas nos deben permitir hacer la toma con la cámara que tengamos conectada.

La imagen debe ser sinónimo de lo que analizamos.

Carta de Consentimiento Informado y Aviso de Privacidad

Proyecto: NEXO-POSTURAL: Kyene'is Pøndyam

NEXO POSTURAL: Kyene'is Pøndyam (Debe estar alineado a la derecha).

V. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Al aceptar, autoriza al personal de NEXO-POSTURAL para la realización de diagnósticos biomecánicos y el tratamiento de sus datos personales conforme a este aviso.

Firma del paciente o tutor

Firma del profesional

La sección de firmas de consentimientos no se encuentra alineadas al mismo nivel.